

Rò Khớp Mu (Rò Nước Tiểu vào Xương Mu)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Khi nước tiểu ăn mòn vào xương mu, gây đau và nhiễm trùng

Rò khớp mu (còn gọi là rò niệu-khớp mu) là đường thông bất thường giữa **đường tiết niệu** (cổ bàng quang hoặc niệu đạo) và **khớp xương mu** ở phía trước xương chậu — thường kèm theo nhiễm trùng xương. Bệnh gây đau vùng mu hoặc bẹn nặng và khó đi lại. Đây là tình trạng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng; tuy nhiên, phương pháp điều trị rõ ràng vẫn có.

Về tình trạng này

Nước tiểu rò rỉ tiếp xúc với xương mu dẫn đến nhiễm trùng xương (**viêm xương tủy**) và phá hủy khớp. Các triệu chứng điển hình:

- **Đau dữ dội vùng mu, bẹn hoặc xương chậu**, thường nặng hơn khi đi lại
- Khó đi lại hoặc không chịu được sức nặng
- Nhiễm trùng đường tiết niệu tái đi tái lại; đôi khi rò nước tiểu

Cơn đau thường bị nhầm ban đầu với viêm khớp hoặc bệnh chỉnh hình, khiến chẩn đoán bị chậm trễ.

Nguyên nhân

Đây hầu như luôn là biến chứng muộn của **điều trị ung thư tuyến tiền liệt** — đặc biệt sau **xạ trị**, thường cùng với một thủ thuật trước đó ở cổ bàng quang hoặc niệu đạo. Mô đã xạ trị lành kém, cho phép nước tiểu ăn mòn vào xương.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Khớp mu (pubic symphysis)

Khớp nối hai xương mu ở phía trước xương chậu.

Rò khớp mu

Đường thông giữa đường tiết niệu và khớp/xương đó.

Viêm xương tủy (osteomyelitis)

Nhiễm trùng xương.

MRI

Phim chụp tốt nhất để thấy xương và đường rò.

Cắt lọc (debridement)

Phẫu thuật lấy bỏ xương và mô bị nhiễm trùng.

Chuyển lưu nước tiểu

Dẫn nước tiểu ra xa vùng tổn thương; thường là biện pháp lâu dài.

TẠI SAO CẦN ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC NHƯ VẬY? Vì vấn đề là **mô và xương bị nhiễm trùng, lành kém (thường đã xạ trị)**, việc chỉ vá lại hiếm khi thành công. Để hết đau lâu dài thường cần lấy bỏ xương nhiễm trùng và **dẫn nước tiểu ra xa vùng đó** — đó là lý do chuyển lưu nước tiểu thường được khuyến cáo. Điểm tích cực là nó có thể chấm dứt nhiều năm đau đớn.

Chẩn đoán như thế nào

- **MRI** vùng chậu (tốt nhất để đánh giá xương) và nội soi niệu đạo/bàng quang
- Cấy vi khuẩn để xác định loại nhiễm trùng
- Khai thác tiền sử kỹ — tiền sử điều trị ung thư tuyến tiền liệt, xạ trị và các thủ thuật đã thực hiện

Điều trị như thế nào

- 1 **Kháng sinh** điều trị nhiễm trùng xương.
- 2 **Phẫu thuật lấy bỏ xương nhiễm trùng** (cắt lọc) và làm sạch vùng tổn thương.
- 3 **Chuyển lưu nước tiểu** — nhiều bệnh nhân cuối cùng cần **chuyển lưu nước tiểu** (và đôi khi cắt bỏ bàng quang/niệu đạo bị tổn thương) vì mô đã xạ trị không thể lành theo cách khác.
- 4 **Vạt mô** — cơ khỏe mạnh hoặc mạc nối có thể được đưa vào để lấp đầy và giúp lành vùng mô.

Điều trị thường cần **phối hợp nhiều chuyên khoa** (tiết niệu cùng chỉnh hình và/hoặc phẫu thuật tạo hình).

Nên biết

- Nếu bạn đau vùng mu không rõ nguyên nhân sau xạ trị tuyến tiền liệt, hãy đề cập tình trạng này — bệnh dễ bị bỏ sót.
- Chuyển lưu nước tiểu nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đây thường là biện pháp **giải quyết đau và nhiễm trùng** hiệu quả nhất.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Sốt, ớn lạnh hoặc cảm thấy rất mệt** (có thể nhiễm trùng lan rộng)
- Đau vùng mu/bẹn ngày càng nặng hoặc **không đi lại được**
- Không tiểu được hoặc chảy máu nhiều

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Rò khớp mu khiến nước tiểu ăn mòn vào xương mu, gây đau dữ dội và nhiễm trùng xương — thường xuất hiện nhiều năm sau xạ trị tuyến tiền liệt.
2. Bệnh thường bị nhầm với viêm khớp; MRI giúp chẩn đoán. Hãy cho nhóm chăm sóc biết về tiền sử xạ trị.
3. Điều trị bao gồm lấy bỏ xương nhiễm trùng và thường chuyển lưu nước tiểu — tích cực, nhưng có thể chấm dứt đau đớn.